20대 남성 다한증 원인부터 치료 순서까지

손·발·겨드랑이 땀이 생활을 방해할 때, 원인 질환이 없는 '원발성'인지 확인하고 단계적으로 치료합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

20대 초반이면 먼저 '원발성 국소 다한증'을 봅니다

원발성 = 특별한 원인 질환 없이 특정 부위에만 땀이 많은 것 — 전신 질환보다 흔합니다

1

흔한 모습

사춘기~20대 초반에 시작해 손·발·겨드랑이에 땀이 많고, 양쪽이 비슷하며, 긴장하거나 더우면 심해집니다.

특정 부위 · 양쪽 · 자는 동안 줄어듦

2

먼저 확인할 경우

온몸에 땀이 나거나 밤에 흠뻑 젖는 경우, 체중 감소·열·두근거림이 함께 있으면 다른 원인이 있는지 **먼저** 살핍니다.

원인 질환 먼저 확인

3

현실적인 목표

땀을 아예 없애기보다 **생활의 불편을 덜기**가 목표입니다. 땀 불편 점수가 1~2점 내려가는지 봅니다.

점수로 효과 확인

Tip · 원발성 다한증은 가족 중에 비슷한 분이 있는 경우가 많습니다.

근거 · 미국가정의학회(AAFP) 2018 다한증 치료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단은 '6개월 + 생활 방해 + 특정 부위'입니다

검사보다 문진과 부위 확인이 먼저입니다

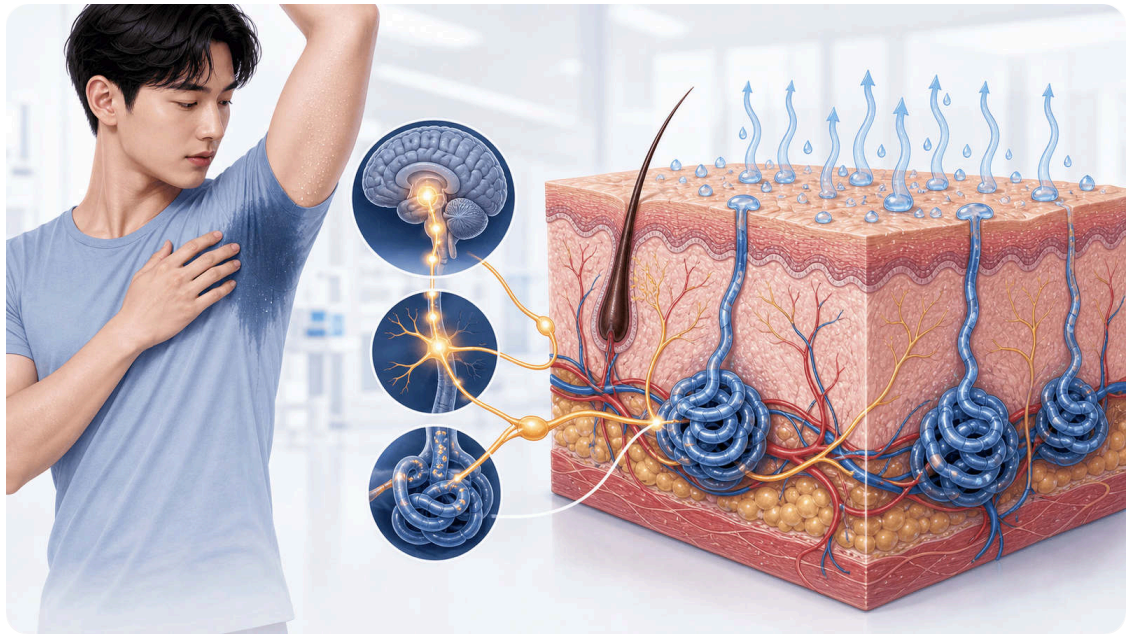


그림 · 신경 신호가 땀샘을 지나치게 자극해 특정 부위에 땀이 많아집니다(설명용 그림).

1 **6개월 넘게** 지속

뚜렷한 원인 없이 특정 부위 땀이 6개월 넘게 되풀이됩니다.

2 **양쪽이 비슷하게** 대칭

한쪽만 심하면 신경·피부의 다른 원인을 찾아야 합니다.

3 **주 1회 넘게 생활을 방해** 기능

악수·필기·운동·대인관계·옷 젖음 등 불편을 묻습니다.

4 **25세 전 시작 · 자는 동안 줄어듦** 경과

가족력도 봅니다. 자면서도 계속 젖으면 전신 원인을 찾습니다.

Tip · 진료 전에 언제·어디서·얼마나 불편했는지 적어 오시면 진단이 빨라집니다.

근거 · 원발성 국소 다한증 진단 기준 · 땀 불편 점수(HDSS)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

부위마다 치료가 달라집니다

손·발·겨드랑이·얼굴을 나눠 기록하면 치료 선택과 의뢰 시점이 분명해집니다

손바닥

악수·필기·휴대폰 터치가 불편합니다. 병역 판정에서는 손바닥 땀 기록이 특히 중요합니다.

발바닥

양말이 젖고 냄새·짓무름이 생깁니다. 손과 함께 이온영동 치료를 고려합니다.

겨드랑이

옷 젖음·냄새가 걱정됩니다. 바르는 약·주사 등 고를 수 있는 치료가 많습니다.

얼굴·두피

사회적 긴장과 잘 연결됩니다. 약 부작용이나 원인 질환을 더 꼼꼼히 봅니다.

심해지는 상황

더위·운동·발표·카페인·매운 음식·스트레스와 어떻게 연결되는지 적어 둡니다.

생활에 미치는 영향

피하게 되는 일, 자신감 저하, 불안·우울이 함께 있는지도 봅니다.

Tip · 부위별로 1~4점을 따로 적어 두면 어떤 치료가 어디에 들었는지 알 수 있습니다.

근거 · 국제다한증학회 · 진료 문진 항목

교육·참고용 — 진단·치료 결정은 담당 의료진과 상의해 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

땀 불편 점수(HDSS)로 심한 정도와 효과를 숫자로 봅니다

'불편하다'를 1~4점으로 적으면 다음 단계가 분명해집니다

점수	느낌	일상생활
1점	거의 불편하지 않음	지장 없음
2점	참을 만함	가끔 방해 받음
3점	참기 어려움	자주 방해 받음 — 치료를 강화합니다
4점	견디기 어려움	늘 방해 받음 — 전문 치료 의뢰를 고려합니다

1점↓ **효과 있음**
땀이 약 50% 줄어든 것으로 봅니다

2점↓ **효과 큼**
땀이 약 80% 줄어든 수준입니다

3개월 **기록**
병역 판정·시술 의뢰에는 진료 기록과 경과가 중요합니다

Tip · 치료 전 점수를 적어 두어야 나중에 얼마나 좋아졌는지 비교할 수 있습니다.

근거 · 땀 불편 점수(HDSS) · 병역판정검사 규칙 다한증 항목

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

겨드랑이는 바르는 약부터 제대로 써 봅니다

효과가 없던 분도 바르는 시간·피부 상태가 맞지 않아 실패한 경우가 많습니다

염화알루미늄 10~20%

마른 피부에 자기 전에 바르고 6~8시간 뒤 씻어 냅니다. 면도 직후·상처·젖은 피부에는 자극이 심해 피합니다.

처방 바르는 약(국소 항콜린제)

겨드랑이용 소프피로니움 5% 겔 등이 있습니다. 바른 뒤 손을 씻고, 눈·입에 닿지 않게 합니다. 시야 흐림·입마름·소변 불편이 생기면 알립니다.

4주 뒤 다시 점수 매기기

한 달을 써도 점수가 전혀 내려가지 않으면 다음 단계로 갑니다. 따가움은 실패가 아니라 횟수·보습으로 조절합니다.



그림 · 샤워 뒤 겨드랑이를 완전히 말리고 자기 전에 바릅니다(설명용 그림).

Tip · 따가우면 이틀에 한 번으로 줄이거나 보습제를 함께 쓰면 계속 쓸 수 있습니다.

근거 · 염화알루미늄 10~20% · 국소 항콜린제 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

손·발은 이온영동이 현실적인 다음 단계입니다

물에 손발을 담그고 약한 전류를 흘리는 치료 — 수술 없이 되풀이해 조절합니다

1 처음 2~4주 집중

주 2~4회, 한 번에 20~30분씩 합니다. 효과가 나면 간격을 늘립니다.

2 유지 치료 주 1회~격주

다시 땀이 나는 간격에 맞춰 조절합니다.

3 먼저 상담할 분 금기 확인

심장 박동기·부정맥·몸속 금속·임신 가능성이 있으면 먼저 알립니다.

4 잘 안 들으면 다음 단계

보툴리눔 독소 주사 — 손바닥은 통증과 일시적 손 힘 약화를 설명드리고 정합니다.



그림 · 물을 담은 쟁반에 손바닥을 대고 약한 전류를 흘립니다(설명용 그림).

Tip · 시술보다 먼저 꾸준한 반복과 유지 계획을 세우면 수술 뒤 생기는 다른 부위 땀 걱정 없이 치료할 수 있습니다.

근거 · 국제다한증학회 치료 흐름도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

먹는 약은 '필요한 상황에 골라서' 씁니다

활동량이 많은 20대는 운동·더위·운전·소변 문제를 함께 따집니다

도움이 되는 경우

짧고 예측되는 상황에 씁니다.

- 시험·면접·발표 같은 날 잠깐 쓰기
- 여러 부위가 함께 불편하고 바르는 약·이온영동으로 부족할 때
- 가장 적은 양부터, 입마름·변비·졸림·시야 흐림을 보며 조절
- 효과가 있어도 부작용 때문에 오래 쓰기 어려울 수 있음

vs

특히 조심할 때

땀을 막아 몸의 열이 빠지지 않을 수 있습니다.

- 더운 곳·격한 운동 — 열 관련 질환 위험
- 시야가 흐려 운전이 불편하면 시간·양을 바로 조정
- 소변이 잘 안 나옴·변비·심한 입마름은 멈추고 상담
- 비슷한 계열의 약을 이미 먹고 있다면 함께 따짐

Tip · 옥시부티닌·글리코피롤레이트 같은 먹는 약은 '항콜린제'라고 부르는 한 계열입니다.

근거 · 먹는 항콜린제 안전성 · 미국가정의학회 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

시술은 부위와 효과 기간을 나눠 고릅니다

바르는 약·이온영동 뒤에도 3~4점이 계속되면 피부과·흉부외과 의뢰를 검토합니다



그림 · 땀 나는 자리를 표시하고 격자로 나눠 주사합니다(설명용 그림).

보툴리눔 독소 주사

겨드랑이에서 근거가 가장 강하고 몇 달 효과를 기대합니다. 손바닥은 통증과 일시적 손 힘 약화를 설명드립니다.

땀 나는 자리 표시

요오드와 전분을 바르는 검사로 땀 나는 면적을 확인하고 격자로 나눠 주사합니다.

미라드라이 — 겨드랑이 전용

건강보험이 안 되고 붓기·감각 이상이 생길 수 있어 오래가는 효과와 비용을 함께 비교합니다.

Tip · 시술은 완치보다 조절입니다 — 다시 맞아야 할 수 있고, 효과 기간·보험·비용을 미리 확인합니다.

근거 · 보툴리눔 독소 겨드랑이 다한증 연구 · 미라드라이 임상 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

온몸 땀은 원인부터, 교감신경 수술은 마지막 선택입니다

원인 질환이 숨어 있거나 수술 뒤 다른 부위에 땀이 늘면 되돌리기 어렵습니다

이럴 때	이렇게 합니다
온몸 · 밤에 흠뻑 · 새로 시작	성인이 된 뒤 갑자기 생겼거나, 밤에 흠뻑 젖거나, 한쪽만 심하면 **원인 찾기**가 먼저입니다
함께 있는 증상	체중 감소·열·림프샘 붓기, 갑상샘 증상, 두통과 함께 혈압이 갑자기 오르면 그에 맞는 검사를 합니다
교감신경 절제술(ETS)	수술 뒤 다른 부위 땀(보상성 다한증)이 흔하고 심할 수 있어, 심한 손 다한증에서 **마지막 수단**으로만 논의합니다
겨드랑이만 불편할 때	수술은 신중히 — 바르는 약·처방 바르는 약·보툴리눔 독소·미라드라이를 먼저 비교합니다

Tip · 밤에 흠뻑 젖는 땀·체중 감소·열·두근거림이 있으면 바로 진료받으세요.

근거 · 이차성 다한증 위험 신호 · 교감신경 절제술 보상성 다한증 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료 뒤 4주 동안 해 볼 여덟 가지

기록이 쌓이면 치료 효과, 병역 서류, 전문의 의뢰 판단이 모두 쉬워집니다

01 손·발·겨드랑이를 나눠 1~4점으로 적기

02 4주 땀 일지 — 시간·상황·젖은 옷·악수 불편

03 바르는 약은 마른 피부에, 자기 전에

04 먹는 약을 쓸 땐 더위·운동·시야·소변 살피기

05 손·발은 이온영동 일정과 금기 상담

06 병역 판정에 필요한 진료 기록은 미리

07 불안·발표 공포·자신감 저하도 말하기

08 밤 땀·체중 감소·열·두근거림은 바로 진료

Tip · 다한증은 참는 병이 아니라 기록하고 조절하는 병입니다.

근거 · 광교바른내과 다한증 초기 추적 계획

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

손·발·겨드랑이 땀으로 불편한 분을 위한 설명자료입니다. 치료 단계와 시술 여부는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국가정의학회(AAFP) 2018 · 국제다한증학회 치료 흐름도 · 원발성 국소 다한증 진단 기준 · 땀 불편 점수(HDSS) · 보툴리눔 독소·미라드라이 임상 자료 · 병역판정검사 규칙

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요